



Malang, 26 Desember 2024

Nomor : 1531/I-PM/DIR/XII/2024  
Lampiran : 6 Halaman  
Perihal : Surat Permohonan Penambahan Dokter Umum

Kepada Yth.  
**Ibu Endang Susilowati**  
**Direktur Utama PT Disa Prima Medika**  
di tempat  
**Pengajuan dari : Rumah Sakit Prima Husada Malang**

Dengan hormat,  
Berikut adalah surat permohonan penambahan staf untuk pemenuhan kebutuhan di unit RS Prima Husada Malang, maka dengan ini kami sampaikan adanya permohonan pengajuan Dokter Umum pada posisi:

| NO | PROFESI & PENDIDIKAN | PENEMPATAN              | KEBUTUHAN | TERSEDIA | KEKURANGAN | JUMLAH PEMENUHAN YANG DIAJUKAN | KETERANGAN                           |
|----|----------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Profesi Dokter Umum  | Instalasi Gawat Darurat | 8         | 7        | 1          | 1                              | Penambahan Dokter Umum IGD           |
|    |                      | Asuransi Center         | 1         | 0        | 1          | 1                              | Penambahan Dokter Umum untuk Casemix |

Demikian pengajuan ini dengan harapan dapat segera disetujui.

Mengetahui,  
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Malang, 26 Desember 2024  
Yang Mengajukan  
SDM RS Prima Husada

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi

Tembusan :  
SDM PT. Disa Prima Medika



## LAMPIRAN

### Dokumen Pengajuan Penambahan Dokter IGD

#### PENGAJUAN DOKTER UMUM IGD RS PRIMA HUSADA MALANG

##### A. LATAR BELAKANG

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan selama 24 jam setiap hari. IGD merupakan tempat penanganan awal pasien sesegera mungkin bagi pasien yang mengancam atau mengalami cedera dan sakit. Namun tidak jarangn pasien datang dalam kondisi yang tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan atau disebut juga *false emergency*.

Prinsip pelayanan pasien gawat darurat berpegang pada pelayanan cepat dan tanggap serta mengutamakan keselamatan pasien. Sehingga dibutuhkan tenaga dokter umum atau dokter jaga yang kompeten dan handal dalam kasus *emergency* agar pasien dapat segera ditangani, diatasi kegawatannya dan keluar dari IGD dalam jangka waktu kurang dari 6 jam, baik pindah ke rawat inap, ruang operasi, atau dipulangkan. Namun jika terjadi peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan, dapat terjadi penumpukan dan kepadatan pasien sehingga waktu tunggu pasien semakin memanjang. Waktu tunggu yang lama akan berimbas pada penanganan pasien, efisiensi waktu, serta kepuasan pasien.

Keselamatan pasien juga merupakan prinsip utama yang menjadi tantangan bagi tenaga medis di IGD karena tuntutan mengenai pelayanan cepat dan tanggap, sehingga dibutuhkan ketelitian tinggi dalam menangani pasien dengan berbagai kasus di waktu yang sama. Tingginya jumlah kunjungan dan variasi kasus beberapa kali menimbulkan insiden keselamatan pasien akibat kesalahan manusia atau *human error*. Sehingga diperlukan Analisa untuk menilai kebutuhan dokter IGD sebagai *leader* tim emergency di IGD.

Pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini juga berada dalam kendali penuh BPJS Kesehatan dimana terdapat kriteria kegawatan yang dapat dijamin oleh BPJS serta adanya persyaratan-persyaratan dalam pengajuan klaim dengan diagnosa tertentu. Hal ini juga dapat menjadi stressor yang dapat mempengaruhi fokus seorang dokter IGD dan dapat berdampak pada risiko terjadinya IKP. Dengan tantangan ini, manajemen RS Prima Husada Malang mengajukan analisa pengajuan dokter IGD berdasarkan permasalahan yang ada dan opsi solusi yang dapat diberikan.

##### B. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di IGD
2. Menghindari terjadinya insiden keselamatan pasien

##### C. PERMASALAHAN

Berikut merupakan permasalahan yang ada di IGD:

1. Adanya komplain pasien mengenai lamanya penanganan dokter IGD terutama saat kunjungan IGD ramai
2. Adanya Insiden Keselamatan Pasien yang disebabkan karena kelalaian dokter IGD (*underdiagnosed, undertreated*)
3. Adanya komplain dari dokter spesialis mengenai dokter IGD yang tidak memeriksa pasien dengan tepat
4. Adanya komplain dari DPJP pasien dan perawat rawat inap mengenai dokter IGD yang tidak memenuhi panggilan bantuan dari perawat ruangan saat IGD sedang ramai.

Setelah dilakukan Root Cause Analysis, penyebab utama permasalahan tersebut adalah ketidakmampuan seorang dokter IGD untuk menangani semua pasien secara maksimal



dalam satu waktu dalam bersamaan, dokter IGD sudah menangani pasien sesuai triase, namun terdapat keterbatasan jika jumlah pasien tinggi. Masalah ini sudah dibahas di forum rapat komite medik, komite etik dan rapat direksi dengan Kesimpulan bahwa diperlukan adanya penambahan dokter jaga dalam 1 shift.

#### D. SOLUSI YANG DIAJUKAN

1. Penambahan satu dokter masing-masing di shift pagi dan sore.
  - a. *Strength*:
    - a) Dapat menangani seluruh pasien dengan lebih cepat
    - b) Dapat memeriksa dengan lebih hati-hati dan tidak terburu-buru karena pasien lain ditangani oleh dokter yang lain
    - c) Salah satu dokter dapat mengatasi kegawatan di ruangan atau menggantikan visit DPJP yang berhalangan ketika tidak ada dokter ruangan (shift sore dan hari libur)
    - d) Menghindari komplain pasien akibat lamanya penanganan di IGD
  - b. *Weakness*:
    - a) Peningkatan jumlah pasien yang tidak stabil bahkan cenderung turun di 2 kuartal terakhir
    - b) Load tinggi tidak selalu berada di salah satu shift sehingga salah satu dokter dapat kekurangan jobdesk
    - c) Menambah beban pembiayaan untuk uang duduk / jasa kehadiran.
  - c. *Opportunity*:
    - a) Kepercayaan masyarakat mengenai pelayanan IGD Rumah Sakit Prima Husada Malang
    - b) Antusias dokter umum dalam recruitment selalu tinggi menunjukkan banyak dokter umum yang ingin bergabung di RS Prima Husada Malang
  - d. *Threats*:

Ketatnya aturan BPJS mengenai kriteria kegawatdaruratan dan aturan BPJS yang menekan FKTP untuk tidak merujuk 144 diagnosa ke RS dapat menimbulkan turunnya jumlah pasien sehingga load di IGD berkurang.
2. Penambahan 1 dokter middle pukul 10.00-18.00 atau 12.00-20.00
  - a. *Strength*:
    - a) Hanya perlu menambah 1 dokter saja sehingga beban penggajian berkurang
    - b) Pada waktu tersebut merupakan waktu dimana terjadi kepadatan IGD sehingga menambah 1 dokter menjadi lebih efektif dan efisien
  - b. *Weakness*:

RS Prima Husada Malang tidak memiliki dokter IGD full timer, dimana dokter-dokter IGD memiliki jadwal praktek di RS / klinik lain sehingga pengaturan jadwal middle akan cukup sulit. Misal dokter A praktek di RS A di shift pagi dan biasanya praktek di RS Prima Husada Malang di shift sore atau malam, sulit mengatur jadwal middle
  - c. *Opportunity*:

Jika diperkenankan open recruitment kembali, dokter lulusan baru / fresh graduate dapat lebih fleksibel dalam pengaturan jadwal
  - d. *Threat*:

Ketatnya aturan BPJS mengenai kriteria kegawatdaruratan dan aturan BPJS yang menekan FKTP untuk tidak merujuk 144 diagnosa ke RS dapat menimbulkan turunnya jumlah pasien sehingga load di IGD berkurang.



3. Pengajuan Program Internship Dokter

a. *Strength*:

- a) Menambah tenaga tanpa menambah beban penggajian
- b) Dapat segera memeriksa pasien triase kemudian dikonsulkan ke dokter definitive sehingga mengurangi keluhan pasien
- c) Dapat melakukan visit pasien rawat inap dan mengatasi kegawatan di rawat inap di luar jam kerja dokter ruangan ketika load di IGD tinggi

b. *Weakness*:

Dokter internship merupakan dokter yang kurang pengalaman sehingga terdapat risiko terjadinya keluhan pasien atau IKP, namun dokter definitive wajib melakukan pengawasan pada layanan yang diberikan oleh dokter internship untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan

c. *Opportunity*:

Program Internship Dokter Indonesia berlangsung sepanjang tahun

d. *Threat*:

Adanya risiko gugatan perdata jika terdapat permasalahan yang ditimbulkan oleh dokter internship.

4. Pengaktifan Layanan Poliklinik Umum

a. *Strength*:

- a) Dapat memfasilitasi pasien *false emergency*, pasien MCU, pasien yang memang ingin bertemu dokter umum dan tidak ke IGD
- b) Mengurangi kepadatan di IGD akibat kasus-kasus *false emergency*
- c) Mengurangi keluhan pasien yang berada di triase hijau karena dapat lebih cepat diperiksa di poli umum
- d) Meningkatkan nilai emergency di IGD
- e) Tidak menambah beban penggajian uang duduk karena dokter pemeriksa merupakan dokter ruangan

b. *Weakness*:

Saat ini belum ada tempat untuk poliklinik umum, dibutuhkan ruangan khusus yang dekat dengan IGD

c. *Opportunity*:

Banyak kunjungan pasien yang ingin konsultasi dokter umum

d. *Threat*:

Kemungkinan munculnya keluhan pasien karena tidak bisa menggunakan BPJS



E. LAMPIRAN

Rata-Rata Pasien / Shift di IGD Januari – November 2024

| NO              | BULAN     | RATA-RATA PASIEN / SHIFT |            |            |
|-----------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                 |           | SHIFT PAGI               | SHIFT SORE | SHIFT SORE |
| 1               | Januari   | 16,67                    | 16,35      | 12,61      |
| 2               | Februari  | 18,58                    | 18,10      | 13,65      |
| 3               | Maret     | 20,23                    | 20,71      | 17,42      |
| 4               | April     | 21,4                     | 22,2       | 18,03      |
| 5               | Mei       | 19,9                     | 23,35      | 16         |
| 6               | Juni      | 17,3                     | 20,13      | 13,56      |
| 7               | Juli      | 16,06                    | 18,71      | 12,64      |
| 8               | Agustus   | 15,64                    | 16,87      | 11,83      |
| 9               | September | 15,9                     | 19,03      | 13,2       |
| 10              | Oktober   | 16,52                    | 19,32      | 13,77      |
| 11              | November  | 17,53                    | 19,4       | 14,86      |
| Rata-rata total |           | 17,8                     | 19,5       | 14,3       |

Malang, 26 Desember 2024

Diajukan oleh,  
PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis

Disetujui oleh,  
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi



dr. Nur Mazidah



## **LAMPIRAN**

### **Dokumen Pengajuan Penambahan Dokter Casemix**

#### **PENGAJUAN DOKTER CASEMIX RS PRIMA HUSADA MALANG**

##### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem casemix merupakan sistem pengelompokan beberapa diagnosa penyakit dengan gejala atau ciri yang sama serta pemakaian sumber daya yang sama serta prosedur atau tindakan pelayanan di rumah sakit dalam grup-grup tertentu. Sistem pembayaran pelayanan kesehatan diberikan secara paket, dimana biaya telah ditentukan sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Keberadaan system casemix memberikan kemungkinan bagi seorang pasien terhindar untuk menjalani perawatan yang tidak diperlukan agar pengobatan yang diberikan lebih efektif dan efisien.

Pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini juga berada dalam kendali penuh BPJS Kesehatan dimana RS Prima Husada bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. RS Prima Husada berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien kepada setiap peserta JKN sesuai isi PKS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit casemix atau unit asuransi center di Rumah Sakit Prima Husada merupakan unit yang bertanggung jawab dalam seluruh rangkaian kegiatan pengajuan klaim sesuai INACBGs kepada pihak BPJS kesehatan atas layanan yang sudah diberikan kepada pasien peserta JKN.

Dengan begitu banyaknya regulasi baru dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan serta risiko terkait klaim pending, dispute dan tidak layak, RS Prima Husada dan unit Asuransi Center khususnya, diwajibkan untuk beradaptasi terhadap semua regulasi dan meningkatkan mutu serta efisiensi biaya pelayanan rumah sakit. Unit Casemix atau Asuransi Center perlu dilengkapi dengan seorang dokter casemix yang mendukung unit asuransi center terutama di bidang medis karena saat ini tim asuransi center dianggotai oleh tenaga koder tanpa ada tenaga kesehatan yang memahami mengenai aspek medis suatu diagnosa atau tindakan. Dokter casemix memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan kordinasi kegiatan koding dan tim rekam medis
2. Menerima konsultasi dari coder terkait aspek medis,
3. Melakukan koordinasi dengan dpjp jika diperlukan konfirmasi mengenai layanan kesehatan yang telah diberikan, konfirmasi pending maupun audit
4. Mengirim serta menjawab klaim pending dan audit dari verifikator bpjs kesehatan
5. Bertanggung jawab mengenai kendali mutu kendali biaya layanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit
6. Bekerja sama dengan kepala unit asuransi center dan pihak lain yang terkait

##### **B. TUJUAN**

1. Meningkatkan mutu dan kualitas unit Asuransi Center
2. Menghadapi tingginya risiko klaim pending dan audit BPJS Kesehatan
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien melalui Upaya Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) yang lebih maksimal
4. Pengambilan Keputusan yang lebih baik karena seorang dokter memahami aspek medis
5. Melakukan koreksi koding pasien JKN rawat jalan dan rawat inap  
Memeriksa berkas klaim pasien JKN



### C. PERMASALAHAN

Berikut merupakan permasalahan yang terkait kebutuhan dokter casemix:

1. Banyaknya regulasi baru dari BPJS Kesehatan, tingginya klaim pending dan audit sehingga dibutuhkan seorang dokter khusus di unit asuransi center karena selama ini hanya ada Kepala Bidang Pelayanan Medis yang merangkap sebagai Kepala Fraud serta dokter ruangan yang juga tupoksinya bertambah menjadi dokter vaksinator ICV dan MCU dengan kondisi saat ini terjadi peningkatan peminat sehingga fokus menjadi berpotensi terpecah.
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis periode selanjutnya bukan dokter.  
Maka dari itu, RS Prima Husada Malang mengajukan dokter casemix untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas.

### D. REQUIREMENT

1. Pendidikan S1 Profesi Kedokteran
2. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang casemix
3. Memiliki pemahaman mengenai INACBGs dan alur pelayanan kesehatan untuk pasien peserta JKN
4. Bersedia bekerja dengan deadline
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik  
Mampu bekerja sama dalam tim

Malang, 26 Desember 2024

Diajukan oleh,

PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis



dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi

Disetujui oleh,

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah